



OMS

Prévention et traitement de la prééclampsie et de l'éclampsie

RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS

Introduction

Les troubles hypertensifs de la grossesse sont une cause importante de morbidité sévère, d'incapacité à long terme et de mortalité pour les mères comme pour leurs enfants. En Afrique et en Asie, près d'un dixième des décès maternels sont associés à des troubles hypertensifs au cours de la grossesse, tandis qu'en Amérique latine, un quart de ces décès sont liés à des complications de ce type. Parmi les troubles hypertensifs constituant des complications de la grossesse, la prééclampsie et l'éclampsie représentent des causes majeures de morbidité et de mortalité maternelles et périnatales. La majorité des décès dus à ces complications sont évitables si les femmes qui en sont atteintes reçoivent en temps utile des soins efficaces. L'optimisation des soins de santé visant à prévenir et traiter les troubles hypertensifs chez les femmes constitue une étape nécessaire vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. L'OMS a élaboré les présentes recommandations sur la base d'éléments factuels dans l'objectif de promouvoir les meilleures pratiques cliniques possibles concernant la prise en charge de la prééclampsie et de l'éclampsie.

Méthodes d'élaboration des directives

Les procédures appliquées dans la mise au point de ces directives, qui sont exposées dans le *Manuel OMS d'élaboration des directives*¹, comprennent : i) l'identification des questions en matière de pratiques cliniques et de politique sanitaire auxquelles il faut répondre ; ii) la récupération des données de recherche actualisées ; iii) l'évaluation et la synthèse des données ; iv) la formulation de recommandations avec la participation de divers partenaires ; et v) l'élaboration de plans pour la diffusion, la mise en œuvre, l'évaluation des effets et la mise à jour.

¹ *Manuel OMS d'élaboration des directives*. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008.

Les éléments scientifiques à la base des recommandations ont fait l'objet d'une synthèse à l'aide de la méthodologie GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation). Pour chaque question déterminante présélectionnée, des profils de données ont été préparés à partir de 19 revues systématiques de la littérature actualisées. Les recommandations finales ont été formulées et approuvées par un groupe international d'experts ayant participé à la Consultation technique de l'OMS sur la prévention et le traitement de la prééclampsie et de l'éclampsie, qui s'est tenue à Genève (Suisse) les 7 et 8 avril 2011. Les experts ont également repéré d'importantes lacunes en termes de connaissances qui devraient être comblées par la recherche fondamentale et ont dressé une liste des thèmes de recherche prioritaires.

Recommandations

La Consultation technique de l'OMS a fait au total 23 recommandations. La qualité des éléments factuels à l'appui de chacune d'elles a été catégorisée comme très faible, faible, moyenne ou grande. Ensuite, en tenant compte de la qualité des éléments factuels et d'autres facteurs (dont les valeurs et les préférences, l'ampleur de l'effet, l'arbitrage entre bénéfices et inconvénients, l'utilisation des ressources et la faisabilité de chaque recommandation), les experts ont classé les recommandations comme fortes ou faibles. En outre, pour être sûrs que chaque recommandation sera comprise et appliquée sur le plan pratique dans le sens voulu, les experts ont formulé plusieurs observations, qui sont consignées au-dessous des recommandations dans le document complet. Au moindre doute concernant l'interprétation d'une recommandation, le lecteur se référera à la version intégrale des directives. Les 23 recommandations sont présentées ci-après sous forme de deux séries : les interventions recommandées et les interventions non recommandées.



Encadré 1: Interventions recommandées pour la prévention ou le traitement de la prééclampsie et de l'éclampsie

Recommandation	Qualité des éléments factuels	Force
Dans les zones où les apports alimentaires en calcium sont faibles, une supplémentation en calcium est recommandée pendant la grossesse (à raison de 1,5-2,0 g de calcium élémentaire/jour) pour prévenir la prééclampsie chez l'ensemble des femmes enceintes, et surtout chez celles à haut risque pour cette pathologie.	Moyenne	Forte
Une faible dose d'acide acétylsalicylique (aspirine, 75 mg) est recommandée pour prévenir la prééclampsie chez les femmes à haut risque pour cette pathologie.	Moyenne	Forte
L'administration d'une faible dose d'acide acétylsalicylique (aspirine, 75 mg) en vue de prévenir la prééclampsie et les complications associées doit débuter avant 20 (+0) semaines de grossesse.	Faible	Faible
Les femmes présentant une hypertension sévère pendant la grossesse doivent être traitées avec des antihypertenseurs.	Très faible	Forte
Le choix de la voie d'administration d'un médicament antihypertenseur pour traiter l'hypertension sévère pendant la grossesse, de préférence à d'autres, doit reposer principalement sur l'expérience du clinicien prescripteur à propos de ce médicament particulier, de son coût et de sa disponibilité locale.	Très faible	Faible
Le sulfate de magnésium est recommandé pour la prévention de l'éclampsie chez les femmes présentant une prééclampsie sévère, de préférence à d'autres anticonvulsivants.	Grande	Forte
Le sulfate de magnésium est recommandé pour le traitement des femmes atteintes d'éclampsie, de préférence à d'autres anticonvulsivants.	Moyenne	Forte
Une cure complète de sulfate de magnésium par voie intraveineuse ou intramusculaire est recommandée pour la prévention et le traitement de l'éclampsie.	Moyenne	Forte
Dans les situations où il n'est pas possible d'administrer une cure complète de sulfate de magnésium, il est recommandé de donner une dose de charge de sulfate de magnésium puis de procéder au transfert immédiat dans un établissement de soins de niveau supérieur dans le cas des femmes présentant une prééclampsie ou une éclampsie sévère.	Très faible	Faible
Il est recommandé d'induire le travail chez les femmes présentant une prééclampsie sévère à un âge gestationnel où le fœtus n'est pas viable ou a peu de chances d'atteindre la viabilité en l'espace d'une ou deux semaines.	Très faible	Forte
Chez les femmes présentant une prééclampsie sévère, un fœtus viable et moins de 34 semaines de gestation, une gestion attentiste est recommandée, sous réserve de l'absence d'hypertension non maîtrisée ou d'aggravation des dysfonctionnements organiques chez la mère et de détresse fœtale, et de pouvoir suivre ces paramètres.	Très faible	Faible
Chez les femmes présentant une prééclampsie sévère, un fœtus viable et entre 34 et 36 semaines de gestation (+6 jours), une politique attentiste peut être recommandée, sous réserve de l'absence d'hypertension non maîtrisée ou d'aggravation des dysfonctionnements organiques chez la mère et de détresse fœtale, et de pouvoir suivre ces paramètres.	Très faible	Faible
Chez les femmes présentant une prééclampsie sévère et une grossesse à terme, une politique d'accouchement précoce est recommandée.	Faible	Forte
Chez les femmes présentant une grossesse à terme et une prééclampsie légère ou une hypertension gestationnelle légère, l'induction du travail est recommandée.	Moyenne	Faible
Chez les femmes traitées avec des antihypertenseurs avant l'accouchement, il est recommandé de poursuivre le traitement antihypertenseur pendant le post-partum.	Très faible	Forte
Le traitement par des antihypertenseurs est recommandé pour les cas d'hypertension sévère pendant le post-partum.	Très faible	Forte

Encadré 2 : Interventions non recommandées pour la prévention ou le traitement de la prééclampsie ou de l'éclampsie

Recommandation	Qualité des éléments factuels	Force
Conseiller le repos à domicile n'est pas une intervention recommandée pour la prévention primaire de la prééclampsie et des troubles hypertensifs de la grossesse chez les femmes considérées comme à risque pour ces pathologies.	Faible	Faible
Le repos alité strict n'est pas recommandé pour améliorer les issues de la grossesse chez les femmes hypertendues (avec ou sans protéinurie) pendant la grossesse.	Faible	Faible
La restriction des apports alimentaires en sel pendant la grossesse dans l'objectif de prévenir l'apparition d'une prééclampsie et de ses complications n'est pas recommandée.	Moyenne	Faible
La supplémentation en vitamine D pendant la grossesse dans l'objectif de prévenir l'apparition d'une prééclampsie et de ses complications n'est pas recommandée.	Très faible	Forte
La prise individuelle ou de manière combinée de supplémentation en vitamine C et E pendant la grossesse dans le but de prévenir l'apparition d'une prééclampsie et de ses complications n'est pas recommandée.	Grande	Forte
Les diurétiques, et notamment les thiazides, ne sont pas recommandés pour prévenir la prééclampsie et ses complications.	Faible	Forte
L'utilisation de corticostéroïdes dans l'objectif spécifique de traiter les femmes présentant un syndrome HELLP n'est pas recommandée.	Très faible	Faible



Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Département Santé et Recherche génésiques
Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20, CH-1211 Genève 27, Suisse
Télécopie : +41 22 791 4171
Courriel : reproductivehealth@who.int
www.who.int/reproductivehealth



WHO/RHR/11.30

© Organisation mondiale de la Santé 2011

Tous droits réservés. Les publications de l'Organisation mondiale de la Santé sont disponibles sur le site Web de l'OMS (www.who.int) ou peuvent être achetées auprès des Editions de l'OMS, Organisation mondiale de la Santé, 20 avenue Appia, 1211 Genève 27 (Suisse) (téléphone : +41 22 791 3264 ; télécopie : +41 22 791 4857 ; courriel : bookorders@who.int . Les demandes relatives à la permission de reproduire ou de traduire des publications de l'OMS – que ce soit pour la vente ou une diffusion non commerciale – doivent être envoyées aux Editions de l'OMS via le site Web de l'OMS à l'adresse http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html

Les appellations employées dans la présente publication et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillé sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif.

La mention de firmes et de produits commerciaux ne signifie pas que ces firmes et ces produits commerciaux sont agréés ou recommandés par l'Organisation mondiale de la Santé, de préférence à d'autres de nature analogue. Sauf erreur ou omission, une majuscule initiale indique qu'il s'agit d'un nom déposé.

L'Organisation mondiale de la Santé a pris toutes les précautions raisonnables pour vérifier les informations contenues dans la présente publication. Toutefois, le matériel publié est diffusé sans aucune garantie, expresse ou implicite. La responsabilité de l'interprétation et de l'utilisation dudit matériel incombe au lecteur. En aucun cas, l'Organisation mondiale de la Santé ne saurait être tenue responsable des préjudices subis du fait de son utilisation.



**Organisation
mondiale de la Santé**